

Sotsiaaltöö kiirabi valdkonnas



Eduard Gusarov, terviseteaduste magister

Brigaadijuht, Tallinna Kiirabi

Tallinna Kiirabi brigaadid puutuvad kokku väljakutsetega eri kategooriatest. On väljakutseid, kus patsient vajab kiiret sekkumist, kuna tal esineb tervisehäire, mis vajab lahendamist kohe, edasilükkamatult. Kuid on ka väljakutseid, mis üldse ei kuulu erakorralise meditsiini pädevusse, vaid on seotud näiteks tööpuuduse, vaesuse, narkomaania, alkoholismi, asotsiaalsete eluviisidega jne.

Vaadates Tervise Arengu Instituudi avaldatud statistilisi andmeid, siis Tallinnas oli 2014. aastal keskmiselt 212,4 kiirabi väljakutset 1000 elaniku kohta. Selle kohta, kui palju nendest väljakutsetest oli seotud hoopis sotsiaalsete probleemidega, andmed puuduvad, kuna kiirabi teenindab kõiki ning eraldi märget selle kohta ei tehta.

Camprell ja Rasmussen (2012) kirjeldavad oma artiklis, kuidas üks Kanada sotsiaaltöötaja veetis kokku 300 tundi ühes kiirabibrigaadis, et jälgida, kas sotsiaaltöö oleks kiirabitöö kõrval võimalik. Üldjuhul jätkub kiirabitöötajatel, arvestades töö tempot, silmi vaid käsiloleva meditsiinilise probleemi jaoks, kusjuures muud elulised probleemid jäävad tihti tähelepanuta.

Patsientide elutingimused ja interpersonaalsed kriisid võivad kiirabimeeskonnal jääda tähelepanuta just kiirete ja ohtlike väljakutsete puhul. Kiirabitöötajad puutuvad kokku psühhosotsiaalsete probleemidega, millega neil pole aega tegeleda, samas erakorralise sotsiaalabi

jõudmine selle vajajani võib aega võtta tunde, eriti kui patsienti ei hospitaliseerita. Kanada kiirabiosakonnas läbi viidud katsest kirjutades kirjeldavad Camprell ja Rasmussen (2012) juhtumeid, millega sotsiaaltöötaja oma vaatluse jooksul kokku puutus. Ühel väljakutsel tegeles tugevaid põletushaavu saanud lapsega kaks kiirabibrigaadi samaaegselt, aga lapse ema ei lastud lapse ligigi. Keegi ei läinud emale seletama, mida lapsega tehakse või mis edasi saama hakkab. Teise juhtumi puhul oli patsiendiks südameprobleemiga teadvuseta meesterahvas, kellega tegeles samuti mitu brigaadi liiget. Keegi aga ei pööranud tähelepanu tema naisele, kes oli uksele vastu tulnud ihualasti, seisnud terve aja sõnagi lausumata kõrval, ei läinud mehega kaasa ega tulnud hiljem ka haiglasse.

Neid juhtumeid analüüsides järeltavad autorid, et oleks tunduvalt parem, kui kiirabitöötajad astuksid välja oma meditsiinilisest mudelist ja pööraksid tähelepanu ka patsiendi ja teda ümbritsevate lähedaste emotsionaalsele seisundile, pakuksid neile tuge ja viiks nad kurssi kõigega, mis toimub. Kiirabitöötajad tunnistasid, et nad satuvad tihti olukorda, kus puutuvad kokku keeruliste psühhosotsiaalsete probleemidega, kuid ei oska puuduliku ettevalmistuse tõttu neile adekvaatselt reageerida. Kiirabitöötajaid ei ole eraldi koolitatud patsiendile psühhosotsiaalse abi andmiseks. Uurimuse autorite arvates

peaksid iga elukutse esindajad tegutsema vastavalt oma väljaõppele, st kiirabitöötajad keskenduma meditsiinile ja sotsiaaltöötajad psühhosotsiaalsetele küsimustele. Väljakutsete kiire iseloomu tõttu pole kiirabitöötajatelt võimalik oodata sotsiaaltöötaja kohustuste täitmist, kuid nii patsiendid kui nende lähedased vajavad erakorralises olukorras sotsiaaltöötaja abi. Sotsiaaltöötajad võiksid mitte ainult tegeleda psühhosotsiaalsete probleemidega seotud 112 kõnedega, mis koormavad kiirabi ressursse (korduvate pöördumistega inimesed, sõltlased, vaimse tervise probleemidega patsiendid), vaid võiksid teha ka otsest koostööd kiirabibrigaadidega keeruliste ja raskete väljakutsete puhul. Selle tulemusel paraneks kiirabi kättesaadavus ka otsest meditsiinilist abi vajavatele patsientidele (Camprell ja Rasmussen 2012).

Kirjeldatud probleemid on ka Eestis erakorralises meditsiinis aktuaalsed. Kiirabi puutub tihti kokku patsientidega või nendega seotud inimestega, kellele oleks hädasti vaja sotsiaalset tuge või lausa erakorralist sekkumist. Viimasel ajal on hästi sage põhjus kiirabi väljakutseks olnud eakate üksindus. Eakad kutsuvad kiirabi, kuna on üksi ja kardavad üksinda olemist. Samuti pole asotsiaalse eluviisiga kodutute inimeste väljakutsed alati tingitud meditsiinilistest probleemidest, sest koha- peal hakkab kiirabi tihti lahendama hoopis probleeme seoses ööbimispaiga leidmisega või tegelema nõustamisega.

Muidugi võiksid kiirabitöötajad võimaluste piires tegelda ka patsiendi lähedastega: kui ruumis on mitu brigaadi liiget, siis kindlasti on kellelgi neist minut aega, et seletada patsiendi

paanikas emale rahulikult, mis lapsega toimub, mis edasi saab ja juhatada talle kätte mingi tegevus (kasvõi näiteks haiglasse minejale koti pakkimine), et ta ei peaks närviliselt seisma ja kõike ainult pealt vaatama.

Loendamatul arvul on olukordi, kus kiirabimeeskond ei jõua teha kõike, mida oleks vaja. Surma konstateerides võivad meedikud anda lahkunu omastele vajadusel rahustit, kuid pikemaks nõustamiseks pole neil aega ja endast väljas inimene jäetakse üksinda koju. Alkohoolismist, ravimsõltuvusest ja tähelepanuvajadusest tehtud väljakutsed on aga lihtsalt kiirabi vale kasutamine, mille tõttu mõni tõsiselt abi vajav patsient võib abi saada liiga hilja. Seetõttu oleks vaja, et tervishoiusüsteemis toimiks kiirabi ja sotsiaaltöötajate koostöö. Võiks olla võimalus, et häirekeskus suunab vajadusel patsiendi, tema omaste ja kiirabitöötajate kõne edasi sotsiaaltöötajale. Ideaalis võiks erakorraline sotsiaalabi olla kättesaadav 24 tundi ööpäevas, et vajadusel saaks sotsiaaltöötaja ka patsiendi juurde kohale kutsuda. Näiteks kui inimesel on tõsine terviserike ja tema lähedane on silmnähtavas paanikas või šokis, siis saaks kiirabibrigaad teha oma tööd ja paralleelselt kutsuda kohale sotsiaaltöötaja, kes tegeleks omastega. Sel juhul saaks brigaad patsiendile abi anda ja muretuult sündmuskohalt haigla poole liikuda, teades, et maha jäänud šokis isik ei ole üksi, vaid saab professionaalset tuge. See teadmine teeks kiirabimeeskonna töö vaimselt kergemaks, sest ei maksa unustada, et kiirabitöötajate töö on psüühiliselt väga kurnav ja läbipõlemisprotsendilt üks kõrgemaid. S

Viidatud allikad

TAI statistilised andmed: pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/Dialog/Saveshow.asp (20.09.2015).

Camprell, H., Rasmussen, B. (2012). Riding Third: Social Work in Ambulance Work. National Association of Social Workers, 90–96.